



FACULTAD DE CIENCIAS DE SALUD

Carrera de Psicología

"RELACIÓN ENTRE LA DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD EN GESTANTES
ATENDIDAS EN UN CENTRO DE SALUD ZÁRATE - SAN JUAN DE
LURIGANCHO, LIMA".

Tesis para optar el título profesional de:

Licenciado(a) en Psicología

Autores:

Olenka María Oblitas Pereyra

Asesor:

Mg. Eder Jesús Orihuela Manrique

Código ORCID: 0000-0002-7447-1601

Lima – Perú

2024

Capítulo 1. Introducción

La depresión y la ansiedad son trastornos mentales comunes en mujeres embarazadas y pueden presentarse simultáneamente (Muhammed et al., 2023). Durante el embarazo, la salud mental de las mujeres es crucial para su bienestar general y el desarrollo saludable del feto. Sin embargo, la atención a las morbilidades psicológicas prenatales, como la depresión y la ansiedad, suele ser insuficiente, lo que resulta en una detección y tratamiento inadecuados (Rahman et al., 2023). A nivel mundial, aproximadamente el 10% de las mujeres embarazadas experimentan trastornos psicológicos durante este período, principalmente depresión (Rahman et al., 2023). Estos trastornos son un problema creciente que puede afectar tanto a la madre como al feto en desarrollo (H Alqahtani et al., 2018).

En esta investigación abordaremos la relación de la depresión y la ansiedad en gestantes. Este problema involucra a múltiples actores, incluidos familiares, profesionales de la salud mental y autoridades de salud pública. La falta de atención oportuna a la depresión y la ansiedad durante el embarazo puede llevar a consecuencias adversas, como un aumento en el consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas, una alimentación deficiente y un incumplimiento de las instrucciones prenatales, retardo en el crecimiento fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer (Mojica et al., 2019).

En el Perú, la prevalencia de la depresión ha aumentado en un 44% en los últimos años (Pariona et al., 2018), y el embarazo, a pesar de ser una etapa de alta vulnerabilidad emocional, a menudo no recibe la atención adecuada en cuanto a salud mental (INSMHDHN, 2022). Según Padilla (2022), la mayoría de las gestantes presentan niveles bajos de ansiedad y depresión leve. Las características comunes entre ellas incluyen ser solteras con una mediana de edad de 24 años, tener un nivel educativo secundario y un salario menor a 1300 soles. El grado de

instrucción, especialmente el nivel secundario, se asocia frecuentemente con niveles de ansiedad en este grupo. La falta de conciencia sobre los riesgos asociados con la depresión y la ansiedad, la relación de estos dos problemas, motivan al investigador abordar esta problemática en su trabajo de investigación de proyecto tesis.

El propósito de esta investigación es determinar la relación entre la depresión y la ansiedad en gestantes atendidas en el Centro de Salud Zárate-San Juan de Lurigancho, Lima. Se pretende investigar si existe una relación entre la depresión y la ansiedad, así como identificar los factores involucrados en esta relación y determinar si la relación es unidireccional o bidireccional. Los resultados de este estudio proporcionarán una base sólida en casos prácticos de psicología, lo que permitirá a los profesionales del área comprender si la presencia de una de estas condiciones influye en la probabilidad de que ocurra la otra, y los niveles de incidencia de cada una de ellas.

El problema central de esta investigación es determinar la relación entre la depresión y la ansiedad en gestantes atendidas en el Centro de Salud de Zárate-San Juan de Lurigancho, Lima. Específicamente, se busca responder a la pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre la depresión y la ansiedad en gestantes atendidas en el Centro de Salud de Zárate-San Juan de Lurigancho, Lima? Esta pregunta será abordada mediante la aplicación de instrumentos que permitan determinar el nivel de depresión y ansiedad, así como determinar la relación entre ambas condiciones. Para abordar mejor esta investigación se plantearon preguntas secundarias que ayudaran a contextualizar mejor la pregunta principal de investigación. Estas preguntas son: ¿Cuál es el nivel de ansiedad en gestantes atendidas en el centro de salud Zárate?, ¿Cuál es el nivel de depresión en gestantes atendidas en el centro de salud Zárate?, ¿Existe diferencias significativas en el nivel de ansiedad en gestantes primerizas y no primerizas atendidas en el

centro de salud Zárate? y ¿Existe diferencias significativas en el nivel de depresión en gestantes primerizas y no primerizas atendidas en el centro de salud Zárate?. Abordar estas preguntas permitirá comprender la naturaleza de los trastornos mentales en este grupo específico de población, identificar los determinantes clave, con la finalidad que a futuro esto sirva como base para mejorar los servicios de atención prenatal y el apoyo psicosocial para promover el bienestar emocional y la salud mental de las gestantes. Basándonos en el enunciado principal y secundarios de investigación el objetivo principal de esta investigación es determinar la relación entre la depresión y la ansiedad de gestantes atendidas en el Centro de Salud Zárate-San Juan de Lurigancho, Lima. Para lograr este propósito, se establecen los siguientes objetivos secundarios: medir el nivel de depresión en gestantes atendidas en el Centro de Salud Zárate-San Juan de Lurigancho, Lima y medir el nivel de ansiedad en gestantes atendidas en el Centro de Salud de Zárate-San Juan de Lurigancho, Lima.

La Teoría Cognitiva de la Depresión de Beck postula que las personas deprimidas tienden de manera consistente y negativa a distorsionar sus percepciones de sí mismas, del mundo y del futuro, las cuales están vinculadas y son características del público evaluado. (E. Giles & F. Shaw, 1987).

El Inventario de Depresión de Beck es una herramienta ampliamente utilizada en la evaluación de la depresión, respaldada por más de 14, 000 estudios empíricos realizados desde su creación en 1961. Se destaca por su consistencia interna sólida, capacidad para detectar cambios en los síntomas depresivos y su validez tanto de constructo como de criterio. Además, ha demostrado ser eficaz en distinguir entre personas deprimidas y no deprimidas, siendo aplicable exitosamente en diferentes contextos culturales a nivel internacional (Pang Wang & Gorenstein , 2021).

Por otro lado Almeida et al. (2023) en su investigación demostró la efectividad del Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) para medir la depresión con una sensibilidad de 87% y especificidad del 73%. Lo que lo vuelve un instrumento ideal para ser usado en esta investigación.

Con respecto al concepto de ansiedad, según Bayrampour et al. (2016), se refiere a la ansiedad relacionada con el embarazo (PrA), este tipo de ansiedad se caracteriza por tres atributos críticos: respuestas afectivas, cogniciones y síntomas somáticos. Además, se identifican tres categorías de consecuencias de la PrA: actitudes negativas, comportamientos de búsqueda excesiva de tranquilidad y comportamientos evitativos. La ansiedad relacionada con el embarazo puede ser percibida como normal o anormal, siendo una indicación saludable del importante rol materno de proteger al feto de daños. Además, la duración de los síntomas de ansiedad durante el embarazo es un factor importante para determinar la gravedad de la ansiedad.

Silva da Paz et al. (2022) investigaron la ansiedad en mujeres embarazadas de alto riesgo hospitalizadas en el Hospital Universitario Lauro Wanderley. Utilizando un diseño observacional y descriptivo, se evaluaron 100 pacientes mediante el Inventario de Ansiedad de Beck. Encontraron que el 68% de las mujeres tenían niveles moderados a altos de ansiedad, manifestando síntomas como taquicardia y nerviosismo. Factores como el trimestre gestacional y antecedentes de abortos se correlacionaron con mayor ansiedad. Se concluyó que estas mujeres necesitan un enfoque de atención multidisciplinario, resaltando la importancia del apoyo familiar en la gestión de la ansiedad durante el embarazo de alto riesgo.

La depresión durante el embarazo se ha asociado con un mayor riesgo de parto prematuro y otros resultados adversos para el bebé. Según un estudio reciente realizado por Jahan et al. (2021) se encontró una asociación significativa entre la depresión materna durante

el primer trimestre y tercer trimestre, y un mayor riesgo de parto prematuro. Los síntomas depresivos, como la tristeza persistente y la falta de interés, pueden tener efectos negativos en la salud materna y fetal, destacando la importancia de identificar y tratar la depresión durante el embarazo de manera temprana.

La investigación sobre la relación entre la depresión y la ansiedad de gestantes atendidas en el Centro de Salud Zárate-San Juan de Lurigancho, Lima, se fundamenta en el reconocimiento de la importancia de abordar la salud mental materna en el período perinatal. La investigación que realizó López et al. (2021) destaca la relevancia de investigar la relación entre la depresión y la ansiedad durante el embarazo, resaltando su impacto en la salud materna y neonatal. Esta revisión proporciona una base teórica para comprender la necesidad de evaluar y gestionar estos trastornos de manera integral en el contexto de la atención prenatal.

La ansiedad durante el embarazo también se ha asociado con resultados desfavorables para el parto. Ulfah et al. (2021) según su investigación la ansiedad materna durante el embarazo se relaciona significativamente con un mayor riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer. Los síntomas de ansiedad, como las preocupaciones excesivas y el miedo al parto, pueden contribuir a un ambiente emocionalmente estresante para la madre y afectar negativamente al feto.

Por otro lado, Yang et al. (2023) han examinado cómo los factores como edad, bajo nivel educativo, residencia en áreas rurales, desempleo, complicaciones durante el embarazo, problemas en la relación marital y un ingreso familiar justo, todos ellos influyen positivamente en los niveles de depresión y la ansiedad durante el embarazo. Esta evaluación ayuda a contextualizar los determinantes sociales y ambientales que pueden contribuir a la manifestación de estos trastornos en las pacientes atendidas en el Centro de Salud Zárate-San Juan de Lurigancho. Además, proporciona una referencia importante para comprender cómo

estos factores pueden interactuar con la experiencia individual de las gestantes y afectar su salud mental durante su embarazo.

En resumen, la revisión realizada por Nielsen et al. (2022) respalda la importancia de investigar la relación entre la depresión y la ansiedad durante el embarazo en un contexto de atención primaria como el Centro de Salud Zárate-San Juan de Lurigancho. Las investigaciones adicionales de Dunkel et al. (2022) proporcionan bases teóricas sólidas para abordar los objetivos específicos del presente estudio, incluyendo la evaluación de la eficacia de las intervenciones y estrategias de manejo de la salud mental perinatal en esta población. Estas referencias bibliográficas son fundamentales para fundamentar la investigación y orientar el diseño y la implementación de intervenciones efectivas en el ámbito de la atención prenatal.

Con respecto al estado del arte de la presente investigación, Solís et al. (2018) investigaron la relación entre el apoyo brindado por la pareja y la incidencia de depresión en mujeres embarazadas durante el tercer trimestre. Realizaron un estudio observacional, analítico de casos y controles, prospectivo y transversal en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante junio y julio de 2017. Se formaron dos grupos de gestantes: uno con diagnóstico de depresión y otro sin depresión. Utilizando instrumentos como la Escala de Depresión Perinatal Edimburgo y un cuestionario sobre el apoyo de la pareja durante el embarazo, se recopilieron datos y se realizó un análisis estadístico. Los resultados demostraron una asociación significativa entre diferentes tipos de apoyo de la pareja (emocional, instrumental, informacional y valorativo) y la presencia de depresión en las gestantes. Específicamente, la falta de apoyo por parte de la pareja se relacionó con un mayor riesgo de depresión en las gestantes, destacando la importancia del apoyo emocional, instrumental, informacional y valorativo de la pareja en la salud mental de la gestante.

En cambio, Vega et al. (2019) examinaron la relación entre la ansiedad y la depresión

en gestantes atendidas en el Hospital San Juan de Lurigancho durante mayo y junio de 2017. Se llevó a cabo un estudio correlacional de corte transversal con una muestra de 45 participantes, utilizando la Escala de Depresión de Edimburgo y el Cuestionario de Autoevaluación de la Ansiedad de Ostrosky-Solís. Los resultados mostraron que un alto porcentaje de las gestantes presentaban síntomas de depresión (82.8%) y ansiedad (68.9%), con una correlación inversa significativa entre ambas variables ($r=-0.748$, $p=0.000$). Además, las distintas dimensiones de la ansiedad también mostraron correlaciones inversas significativas con la depresión. Estos hallazgos resaltan la importancia de abordar adecuadamente los problemas de salud mental en este grupo poblacional para prevenir consecuencias negativas tanto para las madres como para sus hijos, aunque se reconoce la necesidad de investigaciones adicionales para profundizar en esta relación.

Padilla (2022), autor peruano que se vio motivado a desarrollar un estudio en el cual buscó determinar los factores asociados de la ansiedad y depresión en una muestra de gestantes que fueron atendidas en el centro de salud Toribio Castro Chirinos de Lambayeque. Para ello se planteó el trabajo con 101 gestantes entre 18 a 50 años a quienes se les aplicó un cuestionario el Inventario de Depresión y Ansiedad de Beck. Tras analizar los resultados, se halló que el 64% de las participantes eran convivientes, el 64.4% tenían educación secundaria, el 78.2% recibían menos de 1300 soles al mes, el 92.1% no realizaba actividad física, el 84.2% estaban en el tercer trimestre y el 88.1% tuvo un embarazo no planificado. El 74.3% experimentó poca ansiedad y el 31.7% mostró depresión leve. Las gestantes con educación secundaria presentaron los niveles más altos de ansiedad, con frecuencias superiores al 60% en todos los grados, obteniendo un valor p menor a 0.05. En conclusión, los diferentes niveles de instrucción están relacionados con variaciones en los niveles de ansiedad, pero no se identificó un factor específico asociado a la depresión.

Gerges et al. (2023) en su investigación contribuyó a delinear los factores asociados a con la depresión y ansiedad durante el embarazo. Su investigación presentó un diseño transversal. La muestra consistió en 433 participantes mayores de 18 años. Los resultados mostraron que un alto porcentaje de las mujeres experimentaron síntomas de depresión y ansiedad durante el embarazo, con el 87.8% reportando síntomas de depresión y el 70.3% mostrando niveles significativos de ansiedad. Los factores asociados con mayor prevalencia de depresión y ansiedad, fueron dificultades específicas del embarazo, pertenencia a la religión musulmana, temor a agresores existentes, infecciones del tracto urinario y edad gestacional avanzada. Además, un menor índice de actividad física y actitudes alimentarias desordenadas durante el embarazo estuvieron asociados con una menor prevalencia de depresión. Por otro lado, los factores asociados con la ansiedad incluyeron dificultades específicas del embarazo, infecciones del tracto urinario y antecedentes de abuso emocional o físico. En conjunto, estos factores pudieron predecir el 49% de la varianza total en los niveles de ansiedad. En conclusión, el estudio destaca la importancia de identificar y abordar los factores de riesgo asociados con la depresión y la ansiedad anteparto en mujeres embarazadas libanesas, así como la necesidad de implementar programas de detección y tratamiento durante la atención prenatal.

Como hipótesis tenemos: H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre la depresión y ansiedad en las gestantes atendidas en el centro de salud de Zarate de San Juan de Lurigancho. También se plantea hipótesis secundaria para desglosar y segmentar mejor las teorías, tal como: H1a ¿Existe diferencias significativas tanto en la ansiedad como en la depresión en el nivel de depresión en gestantes primerizas y no primerizas atendidas en el centro de salud Zarate?

La depresión y la ansiedad durante el embarazo representan un desafío significativo para la

salud mental de las gestantes. Estos trastornos pueden tener consecuencias adversas tanto para la madre como para el feto, incluidos el aumento del estrés, las complicaciones obstétricas y neonatales, y el deterioro del vínculo madre-hijo. Aunque existen numerosos estudios sobre la depresión y la ansiedad en mujeres gestantes en general, hay una brecha en la literatura científica en lo que respecta a la población adolescente. Investigar específicamente en este grupo demográfico permitirá comprender mejor sus necesidades y desafíos únicos durante el embarazo.

Los resultados de este estudio tendrían una importancia principalmente práctica y social. Desde una perspectiva práctica, proporcionarían información crucial para mejorar la atención prenatal al identificar factores de riesgo y protectores asociados con la depresión y la ansiedad en mujeres embarazadas. Esto podría llevar a intervenciones más efectivas y personalizadas, incluyendo detección temprana, tratamiento adecuado y apoyo psicológico necesario. Desde un punto de vista social, estos resultados serían significativos porque podrían influir en políticas de salud pública y programas de prevención dirigidos a promover el bienestar tanto de las madres como de sus hijos. Al abordar la depresión y la ansiedad durante el embarazo, se podrían evitar consecuencias negativas tanto para las mujeres embarazadas como para sus hijos, lo que tendría un impacto positivo en la sociedad en general. En cuanto a la importancia teórica, los resultados podrían contribuir al conocimiento científico al proporcionar una comprensión más profunda de la relación entre la salud mental de las mujeres embarazadas y los resultados del embarazo. Esto podría servir de base para investigaciones futuras y teorías sobre la salud mental perinatal. Sin embargo, la importancia principal de este estudio parece radicar en su aplicabilidad práctica y su impacto social.

Al centrarse en un contexto específico, como el Centro de Salud de Zárate - San Juan de Lurigancho, Lima, durante un período de tiempo específico, este estudio proporcionara nuevos conocimientos sobre la relación entre la depresión y la ansiedad en gestantes, avanzando así en la

comprensión teórica de este fenómeno. Los hallazgos de esta investigación serán útiles para los profesionales de la psicología clínica que trabajan con mujeres gestantes, brindándoles herramientas y estrategias para abordar de manera más efectiva la salud mental durante el embarazo.

Capítulo 2. Método

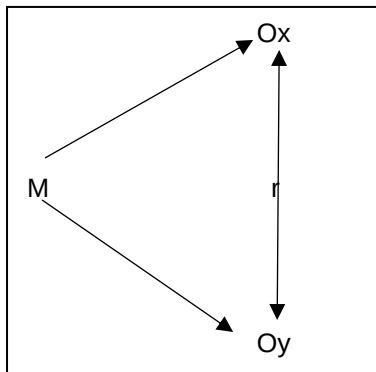
Diseño

Según la explicación del investigador, este estudio se clasifica como observacional, dado que no se manipulará ninguna de las variables bajo estudio (Chandra et al., 2023). En cuanto al control de la medición de la variable de estudio, se trata de una investigación prospectiva, ya que los datos se obtendrán de manera autónoma y se tendrá control sobre su recolección. Sin embargo, debido al hecho de que solo se realizará una medición de las variables en un momento determinado para llevar a cabo los análisis, se considera un estudio transversal (Davis et al., 2023). Además, al involucrar más de una variable de estudio, se clasifica como un estudio analítico. Por lo tanto, se puede concluir que este estudio se enmarca dentro de una investigación observacional prospectiva, transversal y analítica (L. Kau et al., 2024). En cuanto al alcance de la investigación, estará ligada a un nivel relacional, ya que no busca demostrar una relación de causalidad entre las variables, sino cómo están relacionadas entre sí.

Además, el estudio en cuestión se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, ya que tiene como objetivo determinar la relación entre la depresión y la ansiedad en gestantes atendidas en el Centro de Salud Zárate. Para ello, se llevará a cabo la verificación de hipótesis mediante el método estadístico de correlación. Según lo indicado por en la literatura, el enfoque cuantitativo implica el uso de métodos estadísticos y datos numéricos. Este enfoque se caracteriza por la recolección de datos, la formulación de hipótesis, la comprobación de estas hipótesis, que surgen a partir de las preguntas y objetivos establecidos en la investigación, y la medición de las variables seleccionadas para el estudio (Gonzales, 2021).

Figura 1

Diseño de la investigación



Muestra: Gestantes atendidas en el centro de salud de Zárate

Ox: Variable X: Depresión en gestantes

Oy: Variable Y: Ansiedad en gestantes

Población

La población se define como el conjunto completo de individuos que comparten una característica común y que son objeto de estudio (Vizcaíno et al., 2023). En el contexto de esta investigación, la población estará constituida por las gestantes que reciben atención en un Centro de Salud Zárate - San Juan de Lurigancho, Lima. La selección de las gestantes se llevará a cabo mediante criterios de inclusión que definirán los atributos de esta población. Se proporcionará información sobre el tamaño de la población y se identificarán los subgrupos dentro de ella. Dado que trabajar con toda la población no es factible, se justificará la necesidad de utilizar una muestra, especificando su tamaño y el método de selección correspondiente, la cual será de un aproximado de 100 gestantes.

Criterios de inclusión

- Embarazadas igual o mayor de 18 años
- Gestantes capaces de leer y comprender las preguntas.
- Primer embarazo.
- Embarazo en curso; más de 6 semanas de haber iniciado el embarazo para asegurar que el embarazo esté en una etapa adecuada para el estudio.
- Residir en el área geográfica definida para el estudio.

Criterios de exclusión

- Gestantes que no puedan leer o comprender las preguntas del cuestionario.
- Embarazos múltiples, pudiendo ser: gemelos, trillizos, etc.
- Embarazos con condiciones médicas preexistentes o complicaciones significativas como: hipertensión gestacional, diabetes gestacional.
- Gestantes con antecedentes de trastornos mentales graves o en tratamiento psiquiátrico activo.
- Embarazos que hayan iniciado hace menos de 6 semanas.
- Gestantes con un embarazo previamente planificado o con historia de infertilidad tratada.

En esta investigación se llevará a cabo el muestreo por conveniencia, el cual consiste en la recolección de datos de individuos dispuestos a participar en el estudio y que sean los más accesibles o convenientemente accesibles para el investigador (E. Scholtz, 2021).

Control de Mediciones

Para este estudio, se utilizará dos cuestionarios como método de recolección de datos. Según la literatura actual, los instrumentos de investigación representan la parte fundamental de la recopilación de datos, ya que permiten a los investigadores obtener la información necesaria de un tema de estudio (Medina, 2023).

Para la recolección de datos, se aplicarán dos cuestionarios ampliamente reconocidos en el ámbito de la psicología: el Inventario de Ansiedad de Beck y el Inventario de Depresión de Beck. Estos instrumentos han demostrado ser eficaces para evaluar los niveles de ansiedad y depresión en diversas poblaciones, incluidas las gestantes. La elección de estos cuestionarios se basa en su validez y fiabilidad, así como en su capacidad para proporcionar una evaluación integral de los síntomas de ansiedad y depresión. Esta metodología permitirá obtener datos precisos y detallados que facilitarán el análisis estadístico posterior y contribuirán a una comprensión más completa de la relación entre la ansiedad y la depresión en este grupo específico de mujeres embarazadas.

Inventario de Depresión de Beck (IDB-II)

El Inventario de Depresión de Beck, conocido como IDB-II, se desarrolló con el propósito de evaluar la gravedad de la depresión en mayores de 18 años en contextos clínicos. El inventario fue desarrollado por Beck et al. (1961) quien sacó su segunda versión pocos años después (Beck et al., 1996), el instrumento tuvo una validación de la segunda versión publicada

por la editorial Pearson en el 2011 (Beck et al., 2011) y por TEA ediciones en el 2014 (Beck et al., 2014). Para este estudio, se emplearon las propiedades psicométricas de la validación del BDI-II en Perú llevada a cabo por Sánchez (2019). Esta validación se realizó en una muestra de 400 pacientes, con edades comprendidas entre 17 y 71 años, que fueron atendidos en un centro de salud mental para consultas externas. Se realizó un análisis de los 21 ítems, reportando una estructura factorial de dos dimensiones a través del análisis factorial exploratorio que reportó un índice de Kaiser-Meyer-Olkin, muy alto ($KMO = .95$) y con un margen de error muy reducido, siendo estadísticamente significativo a través de la prueba de esfericidad de Bartlett ($X^2 = 3603.2$, $p < .001$). También se recurrió a un juicio de expertos en el que se hizo uso del coeficiente V de Aiken que reportó un valor casi perfecto ($V=.99$), para todos los ítems. En cuanto a la confiabilidad del instrumento se reportó que el coeficiente de correlación item-test tomó valores por encima de .41 a .70, lo cual significa que los ítems toman correlaciones moderadas y altas con el instrumento, representado o evaluando aquello que pretenden. Esto fue corroborado por el coeficiente alfa de Cronbrach que reportó una confiabilidad muy alta ($\alpha = .93$).

En cuanto a la composición del instrumento. La Dimensión 1, denominada cognitivo-afectiva, consta de 13 ítems que evalúan indicadores como tristeza, pesimismo, fracasos del pasado, pérdida de satisfacción, sentimientos de culpa, sensación de castigo, autocríticas, llanto, pérdida de interés, indecisión, inutilidad, cambios en los hábitos de sueño y cambios en el apetito. Estos indicadores se encuentran directamente redactados en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 21 y 23, los cuales tienen cuatro opciones de respuesta con una puntuación que varía del 1 al 4, mientras que los ítems 16 y 18 presentan 6 opciones de respuestas.

La Dimensión 2, conocida como conductual-fisiológica, está compuesta por 8 ítems

que evalúan indicadores como disconformidad con uno mismo, pensamientos o deseos de suicidio, agitación, pérdida de energía, irritabilidad, dificultad de concentración y cansancio o fatiga. Estos indicadores se encuentran directamente redactados en los ítems 7, 9, 11, 15, 17, 19 y 20, los cuales tienen cuatro opciones de respuesta con una puntuación que varía del 1 al 4.

Inventario de Ansiedad de Beck

El inventario de ansiedad de Beck fue desarrollado años después del inventario de depresión, a través de un análisis de propiedades psicométricas (Beck et al., 1988). Posteriormente se realizó una validación por parte de Pearson Educación en el 2012 (Beck et al., 2012) y una adaptación y traducción al español en el 2014 (Beck et al., 2014). En la evaluación de la ansiedad en el estudio, se hará referencia a la validación llevada a cabo por Gómez et al. (2023), donde se reportó mediante un análisis factorial confirmatorio, la estructura factorial del instrumento a través de los índices de ajuste: $\chi^2/gf = 3.82$; CFI = .98; SRMR = .03; RMSEA = .07. Los resultados del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) indican un buen ajuste del modelo a los datos. El índice CFI de .98 sugiere que el modelo propuesto se ajusta muy bien en comparación con un modelo nulo, lo que es excelente. El SRMR de .03 también refleja un ajuste muy preciso entre las correlaciones observadas y las predicciones del modelo. Por otro lado, el valor de χ^2/gf de 3.82 indica que el ajuste es aceptable, aunque ligeramente superior al umbral ideal. Finalmente, el RMSEA de .07 está dentro del rango aceptable, mostrando un ajuste adecuado con un margen pequeño para mejorar. En conjunto, estos índices apoyan la validez del modelo evaluado, mostrando que proporciona una buena representación de los datos. Además se realizó como método adicional un análisis de la validez por convergencia, también denominado validez basada en la relación con otras variables. Este

análisis de validez sugiere una prueba o un constructo está asociado con otras medidas que teóricamente deberían estar relacionadas, para este estudio esas medidas fueron los resultados de otros instrumentos que evalúan ansiedad como el Inventario de ansiedad de Beck versión Argentina y la Escala de ansiedad de Hamilton. De esta manera se reportó ($r = .84$; $p < .001$; $r^2 = .70$). el alto coeficiente de correlación $r = .84$ y el valor de $r^2 = .70$ indican que el constructo evaluado tiene una fuerte asociación con otras variables relacionadas, apoyando la idea de que mide lo que se supone que debe medir. El valor $p < .001$ refuerza la significancia estadística de esta relación, lo que confirma la solidez de la validez convergente. Finalmente, dado que se empleó un análisis factorial, el coeficiente de confiabilidad empleado fue omega ordinal, dado que se cuenta con una matriz de correlación policórica la cual desprende del uso de alternativas de respuesta categóricas agrupadas en una matriz de análisis; este resultado fue muy alto lo cual otorga una prueba válida y confiable ($\omega = .95$).

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), el cual está compuesto por 21 ítems distribuidos en cuatro factores distintos. Este instrumento fue válido en Perú. El primer factor, denominado subjetivo, abarca aspectos relacionados con: (Incapacidad para relajarme (ítem 4), miedo a que suceda lo peor (ítem 5), sensación de inestabilidad e inseguridad física (ítem 8), terrores (ítem 9), nerviosismo (ítem 10), miedo a perder el control (ítem 14) y miedo a morirme (ítem 16). El segundo factor, conocido como neurofisiológico, incluye síntomas físicos y neurofisiológicos de la ansiedad, como el hormigueo o entumecimiento (ítem 1), temblor de piernas (ítem 3), mareo o aturdimiento (ítem 6), temblores de mano (ítem 12), temblor generalizado o estremecimiento (ítem 13), sobresaltos (ítem 17), molestias digestivas o abdominales (ítem 18), palidez (ítem 19). Por otro lado, el tercer factor, autonómico, se refiere a síntomas asociados al sistema nervioso autónomo, tales como palpitaciones o taquicardia (ítem 7), sensación de ahogo (ítem 11) y dificultad para respirar (ítem 15). Finalmente, el cuarto factor, síntomas

vasomotores, contempla sensaciones de calor (ítem 2), rubor facial (ítem 20) y sudoración (ítem 21). Cada ítem del inventario se calificará las sugerencias de puntos de corte para interpretar los resultados obtenidos de la siguiente manera:

- De 00 a 21: Indica una ansiedad muy baja.
- De 22 a 35: Indica una ansiedad moderada.
- Más de 36: Indica una ansiedad severa.

Cada pregunta se puntúa en una escala del 0 al 3, donde el 0 representa "en absoluto", el 1 "levemente, no me molesta mucho", el 2 "moderadamente, fue muy desagradable pero podía soportarlo", y el 3 "severamente, casi no podía soportarlo". La puntuación total se obtiene sumando los puntos asignados a cada pregunta. Los síntomas evaluados corresponden a la experiencia de la última semana y al momento actual.

Procedimiento de recolección de datos

El procedimiento de recolección de datos para la investigación "Relación entre la depresión y la ansiedad en gestantes atendidas en el Centro de Salud Zárate-San Juan de Lurigancho, Lima" se llevará a cabo de la siguiente manera:

1. Identificación de participantes: Se identificarán a las gestantes que estén interesadas en colaborar y participar voluntariamente en la investigación.
2. Información sobre el estudio: Se proporcionará a las gestantes información detallada sobre el propósito y los procedimientos del estudio.
3. Consentimiento informado: Se solicitará el consentimiento informado a todas las

gestantes que deseen participar en el estudio, asegurando que comprendan los objetivos, los riesgos y los beneficios de su participación.

4. Encuesta autoaplicable: Una vez obtenido el consentimiento informado, las gestantes completarán una encuesta autoaplicable que abordará aspectos relacionados con la depresión y la ansiedad. Esta encuesta puede incluir escalas validadas como el Inventario de Depresión de Beck (BDII) y el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI).

5. Seguimiento y clarificación: Se brindará apoyo y clarificación adicional a las gestantes durante el proceso de cumplimentación de la encuesta, asegurando que comprendan todas las preguntas y puedan responder de manera precisa.

6. Confidencialidad de los datos: Se garantizará la confidencialidad de la información proporcionada por las gestantes, utilizando códigos de identificación en lugar de nombres reales y almacenando los datos de manera segura y protegida.

7. Análisis de datos: Una vez recopilados los datos, se llevará a cabo un análisis estadístico para examinar la relación entre la depresión y la ansiedad en las gestantes participantes.

Este procedimiento se llevará a cabo con el objetivo de obtener información precisa y relevante sobre la relación entre la depresión y la ansiedad durante su embarazo en el contexto del Centro de Salud Zárate - San Juan de Lurigancho, Lima.

Análisis de Datos

Inicialmente, se procederá a la construcción de una base de datos en Excel, donde se registrarán las respuestas de los participantes de manera organizada. Posteriormente, los datos

serán exportados al programa IBM SPSS Statistics para su procesamiento estadístico o serán tabulados directamente en el mismo software. El uso del coeficiente de correlación de Pearson será fundamental para explorar la relación entre la depresión y la ansiedad en las gestantes incluidas en el estudio. Este análisis se realizará con un nivel de significancia establecido en 0.05 para asegurar la validez de los resultados obtenidos. Además, se emplearán tablas de frecuencia adecuadas para visualizar la distribución de los datos y facilitar la interpretación de los hallazgos. Esta fase metodológica será crucial para comprender mejor el panorama de la salud mental en este grupo específico de gestantes.

Aspectos Éticos

En términos de los aspectos éticos de esta investigación, en primer lugar, se tomarán en consideración los principios establecidos por el Código de Ética de la Universidad Privada del Norte. Este código, siguiendo las directrices del Código de Ética del Investigador Científico UPN (2016), subraya que los investigadores deben mantener una conducta profesional, dando prioridad a la protección de la privacidad y confidencialidad de los participantes. Esto implica garantizar y resguardar adecuadamente los datos personales recabados durante el desarrollo de este proyecto de investigación.

Referencias

- Almeida, S., Camacho, M., Barahona, B., Oliveira, J., Lemos, R., Rodrigues da Silva, D., Alves da Silva, D., Mourinho, T., Grácio, J., & Oliveira, A. (2023). Validez de criterio y de constructo del Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) para medir la depresión en pacientes con cáncer: la contribución de los ítems somáticos. *Revista internacional de psicología clínica y de la salud*, 23(2). doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2022.100350>
- Barreda Sánchez Pachas, D. V. (2019). Propiedades Psicométricas del Inventario de Depresión de Beck-II (IDB-II) en una muestra clínica. *Revista de Investigación en Psicología*, 22(1), 39 - 52. doi: <https://doi.org/10.15381/rinvp.v22i1.16580>
- Bayrampour, H., Ali, E., McNeil, D., Benzies, K., MacQueen, G., & Tough, S. (2016). Ansiedad relacionada con el embarazo: un análisis conceptual. *Revista internacional de estudios de enfermería*, 55, 115-130. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.10.023>
- Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (2014). Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). Adaptación y traducción al español. Pearson Educación.
- Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (2014). Inventario de Depresión de Beck - Segunda Edición (BDI-II). Adaptación y traducción al español por José A. Sanz y Isabel Vázquez. TEA Ediciones.
- Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (2012). Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). Pearson Educación.
- Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (2011). Beck Depression Inventory - Second Edition (BDI-II). Pearson Clinical Assessment.

- Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Beck Depression Inventory - Second Edition (BDI-II). Pearson Clinical Assessment.
- Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 56(6), 893-897. 10.1037/0022-006X.56.6.893.
- Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. *Archives of General Psychiatry*, 4(6), 561-571. 10.1001/archpsyc.1961.01710120031004.
- Chandra Jaya, A., Azizah, N., & Fikri Aulia, M. (2023). The Relationship Between School Culture And Pro Environmental Behavior Among Senior High School Students In Yogyakarta. *Journal of Innovation in Educational and Cultural*, 5(1), 001-007. doi:<https://doi.org/10.46843/jiecr.v5i1.1064>
- Davis, D., Sheehy, A., Nightingale, H., de VitrySmith, S., Taylor, J., & Cummins, A. (April de 2023). Anxiety, stress, and depression in Australian pregnant women during the COVID-19 pandemic: A cross sectional study. *Midwifery*, 119, 103619. doi:<https://doi.org/10.1016/j.midw.2023.103619>
- Dunkel Schetter, C., Rahal , D., Ponting , C., Julian, M., Ramos , I., Hobel , C. J., & Coussons Read, M. (2022). Anxiety in pregnancy and length of gestation: Findings from the healthy babies before birth study. *Health Psychology*, 41(12), 894–903. doi:<https://doi.org/10.1037/hea0001210>
- E. Scholtz, S. (2021). Sacrifice is a step beyond convenience: A review of convenience sampling in psychological research in Africa. *SA Journal of Industrial Psychology*, 47. doi:<http://dx.doi.org/10.4102/sajip.v47i0.1837>

- Elgavish Accortt, E., D. Cheadle, A. C., & Dunkel Schetter, C. (2015). Prenatal Depression and Adverse Birth Outcomes: An Updated Systematic Review. *Maternal and Child Health Journal*, 19, 1306–1337. doi:10.1007/s10995-014-1637-2
- Gerges, S., Obeid, S., & Hallit , S. (2023). Traversing mental health disorders during pregnancy: Lebanese women’s experiences of antepartum depression and anxiety. *Irish Journal of Medical Science* , 192, 2949–2959. doi:https://doi.org/10.1007/s11845-023-03371-0
- Giles, D., & Shaw, B. (1987). Teoría cognitiva de la depresión de Beck: convergencia de constructos. *Comprehensive Psychiatry*, 28 (5), 416–427. doi: https://doi.org/10.1016/0010-440X(87)90059-9
- Gómez, J. L., Acevedo Flores, K., Cano Tapia, K., Ildefonso De la Cruz, F., Castillo Blanco, R., & Mosquera Torres, D. (2023). Adaptation and Validation of the Beck Anxiety Inventory in Young Peruvians. *Liberabit*, 29(2): e715. doi: https://doi.org/10.24265/liberabit.2023.v29n2.715
- Gonzales, J., & Covinos, M. (2021). Diseño y metodología de la investigación. Recuperado el 22 de Febrero de 2024 de ResearchGate: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias_S2.pdf
- H Alqahtani, A., Al Khedair, K., Al-Jeheiman, R., Al-Turki, H. A., & Al Qahtani, N. H. (2018). Anxiety and depression during pregnancy in women attending clinics in a University Hospital in Eastern province of Saudi Arabia: prevalence and associated factors. *International Journal of Women's Health*, 101-108. doi:https://doi.org/10.2147/IJWH.S153273
- Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi. (30 de Mayo de 2022). Plataforma digital del estado Peruano. Recuperado el 22 de Febrero de 2024, de

Plataforma digital del estado Peruano:

<https://www.gob.pe/institucion/inism/noticias/612846-mujeres-embarazadas-tienen-mayor-predisposicion-a-problemas-de-ansiedad-o-depresion>

Jahan, N., R Went, T., Sultan, W., Sapkota, A., Khurshid, H., A Qureshi, I., & Alfonso, M. (2021). Untreated Depression During Pregnancy and Its Effect on Pregnancy Outcomes: A Systematic Review. *Cureus*, 13(8). doi:10.7759/cureus.17251

L. Kau , A., L. Rosen, A., & Rosas Salazar , C. (13 de January de 2024). Can Therapeutic Targeting of the Human Microbiome Influence Asthma Management? A Pro/Con Debate. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jaip.2023.12.053>

López-Morales, H., Del-Valle, M. V., Laura Andrés, M., Gelpi Trudo, R., Canet-Juric, L., & Urquijo, S. (2021). Longitudinal study on prenatal depression and anxiety during the COVID-19 pandemic. *Arch Womens Ment Health*, 24(6), 1027-1036. doi:10.1007/s00737-021-01152-1

Medina, M., Rojas, R., Bustamante, W., Loaiza. R., Martel, C., & Castillo, R. (2023). Metodología de la investigación. doi: <https://doi.org/10.35622/inudi.b.080>.

Mojica, M., Redondo, S., & Osma, S. (2019). Depresión y ansiedad prenatal: una revisión de la literatua. *Revista de la facultad de ciencias de la salud*, 22(2), 200 - 212. doi: 10.29375/01237047.2820

Muhammed, A., Mehmet Akif , S., Elif Nur , K., Mehmet Sait, D., & Hamza, K. (29 de December de 2023). Prevalence of depression, anxiety, and associated factors in immigrant pregnant women in Türkiye: A cross-sectional study. *Medicine*, 102(52), e36616. doi:10.1097/MD.00000000000036616

- Nielsen Scott, M., Fellmeth , G., Opondo, C., & Alderdice, F. (2022). Prevalence of perinatal anxiety in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 306, 71-79. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.03.032>
- Padilla, L. F. (2022). Factores asociados a ansiedad y depresión en pacientes embarazadas con sars-cov-2 en el Centro De Salud Toribia Castro Chirinos, Lambayeque, 2022. [Tesis de grado – Universidad San Martín de Porres]. <https://hdl.handle.net/20.500.12727/11095>.
- Pagano, A. E., & Vizioli, N. A. (2021). Estabilidad temporal y validez discriminante del Inventario de Ansiedad de Beck. *Liberabit*, 27. doi:<http://dx.doi.org/10.24265/liberabit.2021.v27n1.03>
- Pang Wang, Y., & Gorenstein, C. (2021). Capítulo 16 - El inventario de depresión de Beck: usos y aplicaciones. *ScienceDirect*, 165-174. doi:<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817933-8.00020-7>
- Pariona Gutierrez, E., Moquillaza Alcántara, V., García Cajaleón, J., & Cuya Candela, E. (2018). Psychosocial factors associated with depression in pregnant women treated in a peruvian maternal and child center, 2018. *Revista chilena de obstetricia y ginecología*. doi:<http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262020000500494>
- Pino, E. C., Zuo, Y., H Schor , S., Zatwarnicki , S., C Henderson, D., PC Borba, C., . . . Kalesan , B. (February de 2019). Temporal trends of co-diagnosis of depression and/or anxiety among female maternal and non-maternal hospitalizations: Results from Nationwide Inpatient Sample 2004–2013. *Psychiatry Research*, 272, 42-50. doi:<https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.077>

- Rahman Niazi, A. U., Alekozay, M., Osmani, K., & Fattah Najm, A. (2023). Prevalence and associated factors of depression, anxiety, and stress among pregnant women in Herat, Afghanistan: A cross-sectional study. *Health Sci Rep*, 6(8). doi:10.1002/hsr2.1490
- Sánchez, D. V. B. (2019). Psychometric Properties of the Beck Depression Inventory-II (BDI-II) in a clinical sample. *Revista de Investigación en Psicología*. 22(1): 32-52. doi:<http://dx.doi.org/10.15381/rinvp.v22i1.16580>.
- Silva da Paz, M., Campos, R., Oliveira, M., Oliveira, N., Castro, T., Fernandes, M., Alves, V., Mota, N., & Torres, C. (2022). Analysis of the anxiety level in high risk pregnancy based on the Beck Anxiety Inventory. *Rev. Bras. Saude Mater. Infant.* 22 (04), 1015-1023. doi: <https://doi.org/10.1590/1806-9304202200040016>
- Solís Rojas, M., Salazar Salvatierra, E., & Reyes Gonzále, V. A. (30 de Diciembre de 2018). Depresión en gestantes y el apoyo de la pareja. *Revista Peruna de Investigación Materno Perinatal*. doi:<https://doi.org/10.33421/inmp.2018113>
- Vizcaíno Zúñiga, P. I., Cedeño Cedeño, R. J., & Maldonado Palacios, I. A. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 9723-9762. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658
- Vega Gonzales, E., Guerrero Rosa, A., Guzmán Castillo, B., Huamaní Morales, E., & Herrera Chenett, G. (7 de Septiembre de 2019). Anxiety and depression in adolescent gestants in a lima-peru hospital. *Revista Internacional de Salud Materno Fetal*, 4(3), 3-7. Obtenido de <http://ojs.revistamaternofetal.com/index.php/RISMF/article/view/107>
- Ulfah Suparno, A., Retno Budihastuti, U., & Murti, B. (2021). Meta-Analysis: The Effect of Anxiety During Pregnancy on the Risk of Premature Birth and Low Birth Weight in

Infants. *Journal of Maternal and Child Health*, 6(5), 580-591.

doi:10.26911/thejmch.2021.06.05.08

Yang, H., Pan, Y., Chen, W., Yang, X., Liu, B., Yuan, N., & Zhang, X. (2023). Prevalence of and relevant factors for depression and anxiety symptoms among pregnant women on the eastern seaboard of China in the post-COVID-19 era: a cross-sectional study. (564, Ed.) *BMC Psychiatry*, 23(1), 564. doi:10.1186/s12888-023-05059-2.

.

Anexo 1. Matriz de Consistencia Interna (en caso de ser necesario para la carrera o estudio)

Formulación del Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Método
Propósito Relacional Enunciado Interrogativo ¿Cuál es la relación entre la depresión y la ansiedad en gestantes atendida en el centro de salud Zárate-San Juan de	Objetivo Principal Determinar la relación entre la depresión y la ansiedad en gestantes atendidas en el Centro de Salud Zárate-San Juan de Lurigancho, Lima. Objetivos Secundarios OS1 Medir el nivel de depresión en gestantes que reciben atención en el Centro de Salud Zárate-San Juan de Lurigancho, Lima. OS2 Medir el nivel de ansiedad en gestantes que reciben atención en el Centro de Salud Zárate-San Juan de	H1 Existe una relación significativa entre la depresión y ansiedad en gestantes atendidas en el centro de salud de Zarate de San Juan de Lurigancho. H1a Existe diferencias significativas tanto en la ansiedad como en la depresión en el nivel de depresión en gestantes primerizas y no primerizas atendidas en el centro de salud Zárate?	Variable 1 Depresión D1: Cognitivo Afectiva D2: Conductual Fisiológico Variable 2 Ansiedad D1: Subjetivo D2: Neurofisiológico D3: Autonómico D4: Síntomas vasomotores	Diseño No experimental Enfoque: Cuantitativo Alcance: Explicativo Nivel: Correlacional Tipo: Relacional Corte: Transversal Población Gestantes atendidas en el centro de salud zarate. Mediciones Inventario de Ansiedad de Beck (IAB) Inventario de Depresión de Beck (IDB II) Procedimiento

Lurigancho, Lima?	San Juan de Lurigancho, Lima. OS3 Determinar la relación entre la depresión y la ansiedad en gestantes que reciben atención en el Centro de Salud Zárate-San Juan de Lurigancho, Lima.			Base de datos en Excel Procesamiento de la base de datos en el Programa SPSS. V. 22 en español Análisis de Datos Técnicas descriptivas Prueba de correlación y/o regresión
---------------------------------	--	--	--	--

Anexo 2. Matriz de Operacionalización de las Variables

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Instrumento
Depresión	Es un estado emocional donde la gestante pierda el interés en sus actividades diarias, experimente sentimientos de desesperanza, tristeza y otros síntomas que contribuyen a serias complicaciones tanto para la madre como para el feto (Pino et al., 2019).	Cognitivo Afectiva	Tristeza, Pesimismo, Fracazos del pasado, Perdida de satisfacción, Sentimientos de culpa, Sensación de castigo, Autocriticas, Llanto, Perdida de interés, Indecisión , Inutilidad, Cambios en los hábitos de sueño, Cambios en el apetito y Perdida de interés en el sexo	Pertenece a los siguientes ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 y 21	Inventario de Depresión de Beck II- (DBI-II)
		Conductual Fisiológico	Disconformidad con mi mismo, Pensamientos o deseos de suicidio, Agitación, Pérdida de energía, Irritabilidad, Dificultad de concentración y Cansancio o fatiga.	Pertenece a los siguientes ítems: 7, 9, 11, 15, 17, 19 y 20	
Ansiedad	Es un trastorno subestimado pero prevalente durante el embarazo, caracterizado por preocupación y nerviosismo. Influenciado por factores	Subjetivo	Dificultad para relajarse, Miedo a que pase lo peor, Sensación de Inseguridad, Con miedo o aterrorizado, Nervioso (a), Miedo a perder el control y Con temor a morir.	Pertenece a los siguientes ítems: 4, 5, 8, 9, 10, 14 y 16	Inventario de Ansiedad de Beck
		Neurofisiológico	Hormigueo o entumecimiento, Debilidad en las piernas, Mareos o vértigos, Con temblores en las manos, Inquieto/tembloroso, Asustado,	Pertenece a los siguientes ítems: 1, 3, 6, 12, 13, 17, 18, 19	

	socioculturales y ambientales, como la violencia de género y la falta de apoyo social (Gerges et al., 2023).		Indigestión o malestar estomacal y Sensación de desvanecimientos o desmayos		
		Autonómico	Aceleración del ritmo cardíaco, Sensación de ahogo y Dificultad para respirar	Pertenece a los siguientes ítems: 7, 11 y 15	
		Síntomas vasomotores	Sensación de calor intenso, Rubor facial o sonrojamiento, Sudoración (no producida por calor)	Pertenece a los siguientes ítems: 2, 20 y 21	

Anexo 3. Cronograma del Desarrollo y Culminación de la Tesis

AVANCE DE LA TESIS	ACCIONES	ESTADO	FECHAS															
			Ago-24				Set-24				Oct-24				Nov-24			
			Semanas				Semanas				Semanas				Semanas			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PLANIFICACIÓN DE LA TESIS	Elaboración de la matriz de consistencia interna (plan de investigación).	100%																
	Redactar el capítulo Método y la matriz de operacionalización de variables	100%																
	Estructurar el perfil preliminar del proyecto de tesis, de acuerdo con el formato UPN.	100%																
Presentación final del Perfil de tesis	Corregir las observaciones del Docente Investigador	0%																
Aspectos éticos	Solicitud de permiso para aplicar la encuesta	0%																
Recolección de datos	Aplicación de la encuesta en la población objetivo	0%																

Pág. 34